



基于辨证施护的中医护理对慢性盆腔炎的临床研究

王 晶

(兰州中医骨伤科医院,甘肃 兰州 730000)

摘 要:目的 探讨基于辨证施护的中医护理对慢性盆腔炎患者核心症状的临床效果及满意度。方法 采用随机对照研究,将 84 例慢性盆腔炎患者分为对照组(实施常规护理)和观察组(实施基于辨证施护的中医护理),比较两组患者干预前后的中医证候积分、视觉模拟评分(VAS)及干预后的满意度。结果 干预后,观察组的中医证候积分和 VAS 评分较对照组下降更为明显($P<0.001$),且患者满意度显著高于对照组($P<0.001$)。结论 基于辨证施护的中医护理能够显著改善慢性盆腔炎患者的核心症状,缓解疼痛,并提高其满意度。

关键词:慢性盆腔炎 辨证施护 中医护理

中图分类号: R246.3

文献标识码: B

文章编号: 1671-1246(2025)14-0136-04

Clinical Study on TCM Nursing on Chronic Pelvic Inflammatory Disease Based on Syndrome Differentiation Nursing

WANG Jing

(Lanzhou Traditional Chinese Medicine Hospital of Orthopedics and Traumatology, Lanzhou City, Gansu Province, China 730000)

Abstract Objective To explore the clinical efficacy and satisfaction with traditional Chinese medicine nursing based on syndrome differentiation nursing for chronic pelvic inflammatory disease patients' core symptoms. Methods 84 chronic pelvic inflammatory

基金项目 兰州市科技计划项目“盆腔炎性疾病中医临床护理路径的构建与研究”(2022-5-162)

- [5]莫纪宏.完善紧急状态立法保障公民的宪法和法律权利[J].中国司法,2004(6):5-12.
- [6]习近平.在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作时的讲话[J].求是,2020(7):4-11.
- [7]习近平.加强党对全面依法治国的领导[J].求是,2019(4):4-11.
- [8]习近平.为打赢疫情防控阻击战提供强大科技支撑[J].求是,2020(6):4-8.
- [9]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[N].人民日报,2019-11-06(01).
- [10]习近平.在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话[J].求是,2020(4):4-12.
- [11]张文显.中国法治 40 年:历程、轨迹和经验[J].吉林大学社会科学学报,2018(5):5-25.
- [12]《党的十九届四中全会〈决定〉学习辅导百问》编写组.党的十九届四中全会《决定》学习辅导百问[M].北京:党建读物出版社、学习出版社,2019.
- [13]习近平主持召开中央全面依法治国委员会第三次会议强调全面提高依法防控依法治理能力为疫情防控提供有力法治保障[N].人民日报,2020-02-06(01).
- [14]中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局.马克思恩格斯

全集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1995.

- [15]张富强,孙钰明.公共卫生应急机制与我国政府法治:从非典突发事件看政府依法行政[J].华南师范大学学报(社会科学版),2003(5):8-12,149.
- [16]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利 在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-28(01).
- [17]汪火良.论加强和改善党对法治建设的领导[J].桂海论丛,2014,30(3):80-84.
- [18]李爱芹.我国公共卫生法治保障存在的问题及破解之策[J].中共云南省委党校学报,2021,22(4):166-172.
- [19]习近平.全面提高依法防控依法治理能力健全国家公共卫生应急管理体系[J].求是,2020(5):4-8.
- [20]卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.3版.北京:商务印书馆,2003.
- [21]马怀德,汤磊.总体国家安全观视角下的公共应急管理法治化[J].社会治理,2015(3):32-38.
- [22]袁振龙.把基层党组织这个基础夯实[N].光明日报,2020-04-13.
- [23]冯天瑜.中国文化生成史[M].武汉:武汉大学出版社,2013.

作者简介 刘有斌(1984—),男,博士,讲师。研究方向:马克思主义文化理论、公共卫生管理。△

disease patients were divided into the control group (received routine nursing) and the observation group (received TCM nursing based on syndrome differentiation nursing) with a randomized controlled study. The TCM syndrome scores, Visual Analogue Scale (VAS) scores, were compared between two groups before and after intervention and satisfaction were compared between two groups after intervention. Results After intervention, the TCM syndrome scores and VAS scores in the observation group decreased more significantly than those in the control group ($P < 0.001$), and the patients' satisfaction was significantly higher than those in control group ($P < 0.001$). Conclusion TCM nursing based on syndrome differentiation nursing can significantly improved the core symptoms of chronic pelvic inflammatory disease patients, relieved pain and improve their satisfaction.

Key words 慢性盆腔炎; 辨证施护; TCM nursing

慢性盆腔炎是一种常见的妇科炎症,其病程迁延、易复发,常对患者的生活质量造成显著负面影响^[1]。现代医学主要采用抗感染治疗慢性盆腔炎,但存在复发率高和副作用明显的问题。中医学认为,湿热瘀结、气滞血瘀是慢性盆腔炎的核心病机,通过辨证施护和中医护理技术可有效改善其症状并降低复发率^[2]。然而,目前关于慢性盆腔炎中医护理路径的研究较少,缺乏系统化和标准化的临床实证。本研究基于辨证施护理念,强调因时因人施护,构建并验证了慢性盆腔炎的中医护理路径,以期为该疾病的护理优化提供实证支持。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究于 2022 年 1 月至 2023 年 12 月在我院妇产科开展,共纳入 84 例住院治疗的慢性盆腔炎患者。采用随机分组方法将其分为观察组和对照组,每组各 42 例。对照组年龄 21~46 岁,平均年龄 (31.42 ± 7.73) 岁,初中及以下学历 13 例,高中学历 18 例,本科学历 11 例,体力劳动者 22 例,脑力劳动者 9 例,体力与脑力混合劳动者 11 例。观察组年龄 23~48 岁,平均年龄 (31.66 ± 8.12) 岁,初中及以下学历 16 例,高中学历 14 例,本科学历 12 例,体力劳动者 23 例,脑力劳动者 11 例,体力与脑力混合劳动者 8 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义 ($P > 0.05$),具有可比性。

纳入标准:(1)符合中西医诊断标准。西医诊断参考《盆腔炎症性疾病诊治规范(2019 修订版)》,中医诊断参考《中医妇科常见病诊疗指南》(2012 版)。(2)症状持续 ≥ 3 个月(如下腹痛、腰骶胀痛、带下量多且质地异常)。(3)视觉模拟评分 ≥ 4 分。(4)年龄 18~60 岁,未绝经,有性生活史。

排除标准:(1)盆腔炎症性疾病急性发作者;(2)妊娠期或哺乳期妇女;(3)重要器官患有严重疾病者;(4)病情危重或具有手术指征者(如并发输卵管卵巢脓肿、盆腔脓肿、弥漫性腹膜炎等);(5)无法配合的患者(如患有神经系统或精神疾病,或拒绝合作者)。

本研究方案已通过医院医学伦理委员会的审核。

1.2 研究方法

1.2.1 对照组 接受常规护理干预,依据 2015 年国家中医药管理局发布的《19 个病种中医护理方案》中关于带下证(盆腔炎症性疾病)的中医护理方案实施。

1.2.2 观察组 在对照组常规护理的基础上,实施基于辨证施护的中医护理,强调辨证施护与个体化护理,并根据患者病情变化动态调整护理方案^[3]。通过入院评估、住院护理及出院指导的全过程,实施护理路径的动态管理^[4]。入院时,填写标准化评

估表单,记录中医主症、次症、舌脉象等信息,并结合西医诊断进行初步辨证分型^[5]。在护理过程中,将规范化操作与个性化护理相结合,在确保常用中医护理技术标准化的同时,根据患者体质动态调整护理措施。

(1) 辨证分型。根据慢性盆腔炎的常见中医证型,结合患者的中医诊断,实施个性化分型护理。① 湿热瘀阻型 症状包括下腹胀痛、经期延长、经量增多、带下量多且黄稠臭秽,舌红苔黄腻,脉滑数,护理以清热解毒、利湿化瘀为主^[6]。② 气滞血瘀型:症状包括下腹刺痛、经血排出不畅、月经色暗有血块、情志抑郁,舌质紫暗,脉弦涩,护理以疏肝理气、活血化瘀为重点。③ 寒湿瘀滞型 症状表现为下腹冷痛,得热则缓解,舌淡苔白腻,脉沉缓,护理以温经散寒、化瘀止痛为主^[7]。④ 肾虚血瘀型 症状表现为下腹隐痛、体倦乏力,舌质淡,脉沉细,护理以补肾益气、化瘀止痛为主。

(2) 证候施护。针对不同证型制订护理方案,分为内治和外治两部分。内治措施根据患者证型调整中药方剂,通过中药内服或中成药治疗,以改善盆腔环境、缓解炎症。外治措施根据患者证型,主要实施保留灌肠、艾灸、穴位按摩等中医特色技术,以促进血液循环、缓解局部疼痛。① 保留灌肠 湿热瘀阻型和气滞血瘀型患者采用毛冬青灌肠液 $(39\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 41\text{ }^{\circ}\text{C})$,每日 1 次,保留时间 2 小时以上。月经期暂停操作^[8]。② 艾灸 选取气海、关元、三阴交、肝俞等穴位,根据患者的寒热虚实状态调整灸量和灸法,并适时调整施灸部位。月经期暂停操作。③ 穴位按摩 对关元、血海、三阴交等穴位进行按摩,每次 15~20 分钟。针对气滞血瘀型患者,重点加大推拿力度,增强手法灵活性,确保操作柔和且有针对性和目的性^[9]。④ 中药外敷 采用四黄水蜜调制药物,外敷于盆腹部,配合红外线加热,每日 1~2 次,每次 4 小时。月经期暂停操作。⑤ 耳穴埋豆 主要选取盆腔、内生殖器、内分泌等反射点,每日按压 3~5 次,每次 2~3 分钟,留置 3~7 天。具体穴位根据患者情志状况动态调整。

(3) 因时施护。初期护理(前 3 天)以改善下腹胀痛、带下异常等主要症状为重点,主要采用保留灌肠和中药外敷,同时配合心理疏导,帮助患者缓解身体不适及心理压力。后期护理(第 4~7 天)以调理气血、增强体质为核心,加入穴位按摩、艾灸和耳穴埋豆等护理措施,调整患者体质,预防复发。护理过程中,根据患者的辨证结果动态调整操作内容和频次,并结合住院时间和病情变化制订动态护理计划。同时注意穴位按摩和心理疏导根据患者恢复情况分阶段适时调整频次^[10]。艾灸操作根据患者的寒热表现动态调整,中药外敷安排在下午进行,以促进患者休息,健康教育固定在晨间和晚间进行,帮助患者理解护理内

容并掌握自我管理方法。

(4) 因人施护。根据患者的证型、体质及临床症状调整中药配方,确保药物的针对性。在第1、4、7天重点开展心理干预,结合患者的情绪波动提供针对性支持,缓解其焦虑情绪^[11]。针对不同年龄段患者,提供侧重点不同的健康教育内容,例如,年轻患者加强自我护理知识教育,年长患者重点讲解饮食调理及锻炼方法。加强对不同类型患者的生活起居、饮食指导和情志调理方面的个性化教育^[12]。同时,注意根据证型调整护理措施,湿热型患者避免热敷,寒湿型患者加强保暖。此外,结合证型提供饮食建议,气滞血瘀型患者多食疏肝行气食品,如乌梅、柠檬,少食寒性食物;湿热瘀阻型患者多食清热利湿食品,如苦瓜、冬瓜,忌辛辣刺激、生冷食品。

1.3 观察指标

1.3.1 中医证候疗效积分 中医证候疗效评价参照《中药新药临床研究指导原则》(2002年版)中慢性盆腔炎的中医症状量化评分标准执行。标准将慢性盆腔炎的症状划分为主症与次症两大类,主症包括下腹疼痛或坠胀、腰骶胀痛;次症包括带下异常、月经不调、经行腹痛加重、胸胁乳房胀痛、低热起伏及舌脉象。症状程度分为正常、轻度、中度、重度4个等级,并分别赋予分值,主症依次赋分0、3、6、9分,次症依次赋分0、1、2、3分(除舌脉象外)。需注意的是,舌脉象仅分为正常与异常两类,并不参与积分计算。总分范围0~33分,得分越高,表明中医症状越显著。治疗前后需对症状进行评分,分数下降代表症状改善。分别于干预前后对两组进行症状量化评分。

1.3.2 视觉模拟评分 视觉模拟评分(Visual Analogue Scale, VAS)常用于评估慢性盆腔炎患者疼痛的严重程度。患者需在一条100 mm的横线上标记出当前疼痛的强度,评分越高表明疼痛越剧烈。其中,5 mm以下为无疼痛、5~44 mm为轻度疼痛、45~74 mm为中度疼痛、74 mm以上为重度疼痛。分别于干预前后对两组进行视觉模拟评分。

1.3.3 患者满意度 患者满意度调查涵盖护理技术、沟通质量和治疗效果等多个维度。评分采用百分制,其中,得分>85分为非常满意,60~85分为满意,<60分为不满意。出院时,责任护士对两组患者进行满意度调查。

1.4 统计学处理

本研究采用SPSS 25.0软件进行数据分析,以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。对于符合正态分布的计量数据以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,组内差异采用配对 t 检验进行比较,组间差异采用独立样本 t 检验进行比较。对于不符合正态分布的数据采用非参数检验方法进行分析。此外,等级资料通过秩和检验进行统计分析。

2 结果

2.1 两组中医证候积分比较

干预前,两组的中医证候积分比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。干预后,组间比较结果显示,差异具有统计学意义($t=-7.378, P<0.001$),表明观察组的中医证候积分下降更为明显。干预前后,两组分别进行组内比较,对照组和观察组组内比较结果显示两组差异均具有统计学意义($P<0.001$),说明两组均能有效降低中医证候积分,见表1。

2.2 两组视觉模拟评分比较

表1 两组干预前后中医证候积分比较 $(\bar{x} \pm s, \text{分})$

Table 1 Comparison on TCM syndrome scores between two groups before and after intervention $(\bar{x} \pm s, \text{score})$

组别	<i>n</i>	干预前	干预后	<i>t</i>	<i>P</i>
对照组	42	23.79±4.59	13.48±3.20	18.236	<0.001
观察组	42	22.56±3.93	7.68±2.90	23.460	<0.001
<i>t</i>		0.683	-7.378		
<i>P</i>		0.458	<0.001		

由于视觉模拟评分(VAS评分)不符合正态分布,组内比较采用Wilcoxon符号秩检验,结果显示差异具有统计学意义($P<0.001$)。组间比较采用Mann-Whitney U检验,结果显示观察组的VAS评分改善显著优于对照组,差异具有统计学意义($P<0.001$),见表2。

表2 两组干预前后视觉模拟评分比较 $(\bar{x} \pm s, \text{分})$

Table 2 Comparison on VAS scores between two groups before and after intervention $(\bar{x} \pm s, \text{score})$

组别	<i>n</i>	干预前	干预后	<i>Z</i>	<i>P</i>
对照组	42	21.78±4.54	10.98±3.00	-5.335	<0.001
观察组	42	22.54±3.89	6.65±2.80	-5.360	<0.001
<i>Z</i>		-1.195	-2.544		
<i>P</i>		0.232	<0.001		

2.3 两组满意度比较

干预后观察组患者的满意度显著高于对照组,且差异具有统计学意义($P<0.05$),见表3。

表3 两组满意度比较(%)

Table 3 Comparison of satisfaction between two groups(%)

组别	<i>n</i>	非常满意	满意	不满意	<i>P</i>
对照组	42	57.14	30.95	11.90	<0.001
观察组	42	61.90	33.33	4.76	

3 讨论

本研究结果表明,干预后,观察组的中医证候积分下降更为明显($P<0.001$),观察组的视觉模拟评分改善优于对照组($P<0.001$)。说明基于辨证施护的中医护理路径能够有效缓解慢性盆腔炎的核心症状,改善患者的心理状态。观察组针对湿热瘀阻、气滞血瘀和肾虚血瘀等中医证型实施动态辨证施护,使护理干预更具针对性,提高了个体化护理的精准度^[13]。保留灌肠、艾灸、穴位按摩及中药外敷等护理措施不仅直接作用于病灶,缓解下腹坠胀和疼痛,还能改善局部微循环、调节神经内分泌功能,增强机体的自我修复能力^[14]。在护理过程中,根据患者病情变化和疗效反馈,实时调整护理策略,以优化干预效果,增强护理的针对性和个体适应性,充分体现了中医“因时而治”的核心理念。此外,护理方案结合情志调理,针对患者的情绪波动与心理需求实施个性化健康教育干预,提供心理疏导,使护理更符合个体特点。最后,“以患者为中心”的护理模式不仅增强了患者的治疗信心,还提升了其整体健康素养,使其能够更好地进行自我健康管理,从而实现中医护理“治未病”的预防目标^[15]。

3.1 基于辨证施护的中医护理路径能够缓解慢性盆腔炎症状

本研究结果显示, 观察组干预后中医证候积分显著降低, 表明基于辨证施护的中医护理路径在改善慢性盆腔炎核心症状方面具有较好的临床疗效。这种疗效的取得与观察组根据辨证分型实施个性化护理密切相关。慢性盆腔炎病机复杂, 涉及湿热瘀阻、气滞血瘀、寒湿瘀滞和肾虚血瘀等多种证型, 不同病理机制决定了个体化护理干预的必要性。对湿热瘀阻型患者采用中药保留灌肠结合中药外敷, 以清热利湿、活血化瘀、消肿止痛, 可有效延长药物在肠道的作用时间, 提高药物吸收率, 从而加速炎症消散并改善局部血液循环^[16]。对气滞血瘀型患者采用穴位按摩结合中医手法, 如推腹法, 按揉气海、关元等穴位, 以行气活血、疏通经络、缓解疼痛。中医技术可有效改善盆腔气血循环, 显著缓解气滞血瘀型慢性盆腔炎患者的腹胀刺痛症状^[17]。对肾虚血瘀型患者的护理策略侧重温补灸法、饮食调理及针对性穴位(如太溪、肾俞)按摩, 以补肾活血、扶正祛邪、改善体质。对寒湿瘀滞型患者, 护理中强调艾灸与温热敷贴相结合, 以温经散寒、化湿活血, 增强盆腔免疫功能, 减少炎症复发, 提高治疗效果。辨证施护强调基于病机规律的整体干预, 而因人施护则更关注个体症状和具体病情的动态变化。观察组在辨证施护、证候施护、因时施护和因人施护的综合应用中展现了显著优势。

3.2 基于辨证施护的中医护理路径能够改善患者的心理状态

本研究结果显示, 干预后两组患者的 VAS 评分均显著下降 ($P<0.001$), 且观察组评分改善显著优于对照组 ($P<0.001$)。说明基于辨证施护的中医护理路径能够有效缓解慢性盆腔炎引起的疼痛和不适, 减少患者的焦虑和抑郁情绪, 改善其心理状态, 提高生活质量, 对整体康复具有重要意义^[18]。此外, 护理过程中根据患者病情变化动态调整中医护理技术的频次, 并针对不同体质患者灵活选择干预部位, 提高了患者的依从性, 使其在护理过程中感受到人文关怀, 消除了恐惧感。最后, 护理路径中的情志护理方法, 如提供放松训练、指导患者调节呼吸和进行冥想练习, 也有助于降低其焦虑水平, 改善其心理状态^[19]。

3.3 基于辨证施护的中医护理路径能够提高患者的满意度

本研究结果显示, 干预后观察组患者满意度显著高于对照组 ($P<0.05$)。这一结果不仅反映了患者对核心症状缓解的认可, 还凸显了中医护理在整体护理体验上的优势。与传统护理模式相比, 中医护理路径更注重个体化、温和性和整体观, 在治疗过程中提供了更加舒适的护理体验, 避免了过度依赖药物或侵入性治疗带来的不适感。本研究采用的个性化健康教育策略, 通过耐心与患者沟通, 详细解释疾病的发病机制、护理措施及其效果, 尊重患者的意见和需求, 并鼓励患者参与护理决策, 从而提升了患者的满意度水平。此外, 观察组通过定期评估病情和反馈护理效果, 使患者能够清晰地看到自身健康的改善, 进一步提高了他们对护理工作的积极评价^[20]。

参考文献:

- [1] 蔡福梅, 魏绍斌, 李茂雅, 等. 盆腔炎性疾病及其后遗症的中西医结合治疗现状及问题探讨[J]. 现代中医临床, 2024, 31 (4) : 1-7.
- [2] 覃娟梅. 盆腔炎性疾病的中医护理方法与效果[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2018, 3 (5) : 107, 115.
- [3] 魏樛君. 运用辨证论治理念进行妇产科疾病管理的优势分析[J]. 中医药管理杂志, 2023, 31 (12) : 120-122.
- [4] 赵俊英, 黄少兰, 付海英, 等. 中医护理技术规范及推广模式的构建研究[J]. 护理研究, 2020, 34 (21) : 3890-3895.
- [5] 周继红. 中医辨证施护对慢性盆腔炎患者的临床疗效观察[J]. 长春中医药大学学报, 2020, 36 (2) : 362-364.
- [6] 刘佳, 盛丽, 张宝洲, 等. 温经化瘀汤治疗寒凝血瘀型慢性盆腔炎的疗效观察[J]. 卫生职业教育, 2015, 33 (20) : 154-156.
- [7] 李利玲, 徐铮铮, 张爱洁, 等. 化瘀祛湿汤保留灌肠联合电磁波、常规治疗对慢性盆腔炎患者的临床疗效[J]. 中成药, 2022, 44 (6) : 1810-1814.
- [8] 游宇园, 杨秀云, 何舒灵. 中医辨证施护结合中药灌肠对慢性盆腔炎的治疗效果[J]. 中西医结合护理(中英文), 2023, 9 (5) : 57-60.
- [9] 韦娟姿. 健康教育在穴位贴敷配合中药内服治疗慢性盆腔炎患者中的应用[J]. 齐鲁护理杂志, 2016, 22 (15) : 122-123.
- [10] 邵雅双, 苏倩, 吴白女, 等. 中医护理方案实施质量评价体系的构建[J]. 中华护理杂志, 2024, 59 (18) : 2244-2250.
- [11] 种世桂, 王琼, 何红英, 等. 中西医护理联合 KAP 认知干预对肠造口患者生活质量的影响[J]. 卫生职业教育, 2024, 42 (24) : 69-72.
- [12] 李娟, 张立环, 马彦苗, 等. 健康教育路径护理联合盆底康复训练在产后盆底康复中的应用效果观察[J]. 甘肃中医药大学学报, 2023, 40 (6) : 129-133.
- [13] 王艳琴, 缙燕华. 中医治疗盆腔炎性疾病后遗症的临床研究进展[J]. 河北中医, 2024, 46 (12) : 2104-2108.
- [14] 高瑞, 高川. 中医辨证施护结合常规护理在慢性盆腔炎患者中的应用效果[J]. 临床医学研究与实践, 2023, 8 (18) : 175-178.
- [15] 李娜, 邹红霞, 冯欢, 等. 基于临床需求的中医护理决策支持系统的构建与应用[J]. 中国护理管理, 2024, 24 (9) : 1286-1291.
- [16] 马力凤, 龚燕岚. 盆腔炎病人中药保留灌肠时间和插管深度研究进展[J]. 护理研究, 2018, 32 (24) : 3829-3830.
- [17] 谢小男, 倪光夏. 通调三焦针刺法治疗气滞血瘀型慢性盆腔炎临床疗效观察[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35 (1) : 473-476.
- [18] 刘娜, 李娜, 白翠花. 希望感提升下心理干预对慢性盆腔炎患者负面情绪和健康行为的影响[J]. 心理月刊, 2024, 19 (20) : 142-144.
- [19] 聂群. 心理应激对策在慢性盆腔炎患者护理中的应用[J]. 儿科健康导刊, 2025, 4 (2) : 166-169.
- [20] 詹丽瑶. 辨证中医护理方案在临床实践中的应用路径与效应分析[J]. 中医药管理杂志, 2022, 30 (19) : 92-94.

作者简介: 王晶(1992—), 女, 主管护师。研究方向: 妇产科护理。▲

欢迎查阅《卫生职业教育》 本刊论文查询下载地址: 中国知网 万方数据 维普数据库 超星 博看 长江文库
欢迎投稿《卫生职业教育》 本刊唯一投稿方式为邮箱: wszyjyzzh@163.com